

서형 관영 코멘트



이전 ‘금연 상담’과 ‘음주 문제’로 나뉘어 있던 항목이 합쳐지게 되었습니다. 따라서 금주와 금연이 동시에 필요한 표준화 환자가 나올 가능성이 생겼습니다.

“담배를 끊고 싶어요” 혹은 “술을 끊고 싶어요”와 같은 명확한 주소가 있는 환자일 수도 있지만, 다른 경우에는 술과 담배 둘 모두에 대해 파악하고, 금주와 금연을 함께 권고하는 것이 필요할 수 있습니다.

상담 파트에서는 환자와의 관계 쌓기가 중요하고, **지시문에 따라 신체 진찰이 없을 수도 있으니** 충분한 시간을 들여 라보를 쌓도록 하세요. 신체 진찰이 포함되어있다면 시간이 빠듯할 수 있으니 각각의 상황을 대비하는 것이 중요합니다. 문진도 중요하지만 **교육에 최소 4분 정도 시간이 필요하므로** 시간 조절을 잘 해야 합니다.

환자의 의지에 따라 상담 교육의 방향이 달라질 수 있습니다. 금주/금연 의지가 확고한 환자에게는 방해 요인을 피하고 약물 치료를 병행하는 방법으로 진행할 수 있습니다. 만약 환자가 **당장 끊을 의지가 없이** 보호자의 설득으로 인해 온 환자라면 **금주/금연의 장단점**을 설명하며, **설득하는 방향으로 진행**해야 할 것입니다. 또한 아무리 시간이 부족해도 환자와 다음 만남을 확실히 정하고 끝을 맺어야 합니다.

음주 문제 환자에서는 먼저 알코올 사용장애가 있는지 알기 위해 **CAGE screening**을 하는 것이 중요합니다. 또한 **금주를 하게 된 계기, 예전에 금주를 했던 경험, 그리고 실패했던 이유**에 대해서 물어봐야 합니다. 현재 신체에 문제가 있지 않은지, **어떤 증상을 호소**하는지 알아야 합니다. 음주 문제나 간질환의 가족력이 있는 경우, **신체적 질환을 시사하는 증상**들을 호소할 때는 건강에 문제가 있을 수 있기 때문에 꼭 검사를 해야 한다고 말해야 합니다. 술을 당장 완전히 끊으면 힘들 수도 있으니 **조금씩 줄여나가면서 완전히 끊도록 적절히 회유**를 해야 하고, **인터넷 금주 모임이나 성공 사례**들을 소개해 줄 수 있고, **필요하다면 약물 처방**을 하여 도움을 줄 수 있다고 말합니다.

금연 상담에서는 **의존성을 묻는 질문 5가지**를 꼭 하는 것이 중요합니다. 또한 과거 금연 시도가 실패했던 경험이 있는 경우 **당시 실패 원인, 금단 증상**에 대해 잘 물어보고 환자에게 알맞은 도움을 주는 것이 중요합니다. 금주/금연 시 발생했던 금단 증상에 대해 자세히 물어보는 것이 중요합니다. 단순히 금단 증상이라고 물어봤을 때 대답을 안해주는 경우가 많기 때문에 각각의 경우에 해당하는 금단 증상이 무엇인지 정확히 알고 있는 것이 필요하겠습니다.

상황		특성	면담 전략		예시
음주	과음	생활 문제는 없음 자주 마심	음주 위험 알리기 몸 상태에 문제가 발생할 수 있음 알리기	술 마시는 횟수를 줄이자	매일 캔 맥주 2~3개 정도
	폭음	생활 문제는 없음 가끔 많이 마심		폭음 시에는 소화기 궤양 등 신체적 문제가 발생 할 수 있다.	가끔 한번에 3병까지 마심
	알코올 사용장애★	법적인 문제 발생 대인 관계 문제 내성 금주 실패 시도		술 때문에 법적인 문제가 더 발생하면 안 됨 건강 문제와 관련하여 호소 가족력과 관련하여 호소	음주 운전을 하다 면허 취소 술 점점 더 많이 마심
	알코올 금단	술을 끊고 나서 금단 증상 발생		지지적으로 접근(힘든 일인 데 잘 하고 계신다, 도와 드리겠다)	술 끊고 손 떨림
흡연	계획 전 단계	금연 의도 없음	흡연 위험 알리기 금연 이익 알리기 금연 방해 요인 알기	적절한 동기 부여	담배 피던 고등학생
	계획 단계	금연 의도만 있음		동기 강화 및 금연 계획	특별한 질병은 없으나 주변 권유
	준비 단계★	1개월 내 금연 예정		동기 강화 및 금연 시작일 정하기 금단 증상 대처법/보조 약물 선택	특별한 질병 주변인의 사망 입대/기념일

STEP 1 병력 취취

	금주	금연
행태	[기간] 언제부터 술을 드셨나요? [빈도] 얼마나 자주 드시나요? [양] 술을 드실 때 얼마나 드시나요? (일주일에 몇 회, 한 번에 소주로 몇 병) [최대] 최대로 많이 마실 때는 얼마나 드시나요? [형태] 빨리/많이/섞어서 드시나요?	[언제] 언제부터 담배를 피셨나요? [양] 담배를 하루에 몇 개비 피시나요?

금주/ 금연 의도	앞으로 1개월 내에 금주(절주) or 금연하실 계획이 있으신가요? 금주(절주) or 금연을 결심하게 된 계기가 있으신가요?	
음주/ 흡연 이유	술은 마시는 or 담배를 피는 주된 이유가 어떤 것인가요? (스트레스, 주변 사람, 습관) 술/담배를 누구와 함께 마시나요/피우나요?	
의존성	C(cutdown) : 술을 끊거나 줄여야겠다고 느끼신 적이 있나요? A(annoy) : 술로 인해 다른 사람으로부터 비난을 받은 적이 있나요? G(guilty) : 술 마시는 것에 대해 죄책감을 느낀 적이 있나요? E(eye-opener) : 아침에 해장술을 마신 적이 있나요?	- 아침에 일어나서 얼마 만에 첫 담배를 피우시나요? - 5분 이내 (3점) - 6~30분 이내 (2점) 금연 구역(교회, 극장, 도서관)에서도 흡연을 참기 힘드신가요? - 예 (1점) - 아니오 (0점) - 하루 중에 어떤 때 가장 담배 맛이 좋나요? - 아침 첫 담배 (1점) - 다른 때 피우는 담배 (0점) 하루에 몇 개피를 피우시나요? - 31개피 이상 (3점) - 21~30개피 (2점) 아침에 일어나서 첫 몇 시간 동안 하루 다른 때 보다 더 자주 담배를 피우시나요? - 예 (1점) - 아니오 (0점) - 하루 중 대부분을 누워서 지낼 만큼 몸이 아파도 담배를 피우실 것인가요? - 예 (1점) - 아니오 (0점) 암기법 > 하루의 첫 담배는, 맛이 중요해서 아파도 아침에 금연 구역에서 핀다.
금주/금연 시도 실패 요인 (Roadblock)	이전에 금주/금연을 시도해 본적 있나요?/얼마나 오래 금주/금연하셨나요? 실패했던 이유는 무엇이라고 생각하세요? 주로 금주/금연을 방해하는 요소는 어떤 것이 있을까요?	
금단 증상	금주했을 당시에 어떤 금단 증상이 있었나요? - 불안/우울/불면/손떨림/식은땀/메스꺼움/구토/환청/환시/두근거림/경련	금연했을 당시에 어떤 금단 증상이 있었나요? - 불안/우울/불면/짜증/식욕 증가/체중 증가/두근거림

내성	[양] 같은 정도로 취하기 위해 술 마시는 양이 점점 더 증가하나요? [시간] 술 마시는 시간이 점점 늘어나는지요?	[양] 담배를 피우는 양이 점점 더 증가하나요?
남용	[법적] 술/담배와 관련된 법적 문제가 있었나요? [관계] 술/담배로 인해서 대인 관계가 나빠지지는 않았나요? [의무] 술/담배 때문에 지각, 결근 등 사회적 의무를 못 다하지는 않았나요? [활동] 술/담배로 여가 활동 시간을 포기하게 되나요? [신체] 술/담배로 인해 신체에 외상을 입거나 병들게 한 적이 있나요? 암기법 법관의 여신 설명 대법원 앞에 있는 정의의 여신상을 떠올리세요!	
Relevance	A [전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [소화기] 식욕 변화/오심/구토/설사/복통/혈변/토혈/소화불량/속쓰림 [알코올성 기분장애] 우울/의욕 저하 [알코올성 불안장애] 과도하게 걱정하거나 불안하세요? [알코올성 기억장애] 기억력에 문제가 있나요?/필름이 끊긴 적이 있나요? 암기법 술 마시면 속이 쓰리고, 기억이 안 나면 불안하고 기분이 안 좋다.	[전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [호흡기] 기침/가래/호흡곤란/흉통/쌔쌔거림/객혈/최근 감기 [구강] 치아 변색/구강 내 종양
	E	[건강 검진] 건강 검진에서 이상이 있었나요?
	외	[수술] 입원하거나 수술한 적 있나요?
	과	고혈압/당뇨/고지혈증/심장 질환/호흡기 질환 정신건강의학과에서 음주/담배/약물 남용 문제로 치료받은 적 있으신가요?
	약	드시는 약물이 있으신가요?
	사	직업이 어떻게 되시죠? → 스트레스를 많이 받으시나요?
	가	가족 중 고혈압이나 간질환/폐나 호흡기 질환을 가지고 계신 분이 있으신가요? 가족 중에 술/담배 문제를 가진 분이 있나요?

Risk	술을 드시면 어떤 점이 위험한 지 알고 계신 것이 있나요? [설명] 네, 잘 알고 계시는군요. 환자 분께서 아시고 계시는 것처럼 술을 너무 많이 마시면 간에 무리가 갈 수 있고, 간염과 간경변이 발생할 수 있습니다. 식도와 위에도 염증을 일으키고, 고혈압과 뇌출혈이 더 잘 생길 수 있습니다.	흡연을 하시면 어떤 점이 위험한 지 알고 계신 것이 있나요? [설명] 기본적으로 폐암을 유발할 수 있으며, 협심증, 심근경색을 포함한 심혈관계 질환 및 위궤양, 역류성 식도염을 일으킬 수 있습니다. [부가 설명] - 정자 및 성기능 저하 - 입냄새 및 누런 치아 - 피부가 푸석해지고 탈모가 일어날 수 있으며, 골다공증도 유발 - 임신 예정 : 태아의 호흡기 및 알레르기 질환을 유발
Reward	금주를 하면 어떤 좋은 점이 있는지 알고 계시나요? [설명] 네, 그것과 더불어서 앞서 말씀드렸던 질환이 생길 확률이 줄어드는 것은 물론, 환자분의 신체 활동 능력 자체가 전반적으로 향상될 수 있습니다. 또한 술 한 병이 이천원 정도한다고 생각한다면 매일 두 병만 마셔도 한 달에 12만원인데, 이 돈으로 할 수 있는 것도 참 많을 것이라 생각이 듭니다.	금연을 하면 어떤 좋은 점이 있는지 알고 계시나요? [설명] 네, 그것과 더불어서 앞서 말씀드렸던 질환이 생길 확률이 줄어드는 것은 물론, 환자분의 신체 활동 능력 자체가 전반적으로 향상될 수 있습니다. 또한 담배 한 갑에 5,000원이라고 잡는다면 하루 한 갑을 피는 경우 한 달에 15만원 절약이 가능합니다. → 15만원이면 무엇을 할 수 있는지 생각해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.

STEP 2 신체 검진

P / E	신체 진찰이 생략될 수 있습니다. 이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? [앉아서] 1. G/A : 의식/정신 상태(우울, 불안, 섬망) 확인, 전반적인 위생 상태, 영양 상태 확인 2. 눈 : 결막, 공막, 안구진탕 3. 입 : 치아 변색, 구강 내 종양 4. 흉부 : 호흡음, 심음 청진 5. 손 : 손바닥 angioma + flapping tremor [누워서] 6. 복부 : 시-청-타-촉 → 복부 통증, 간비대, 복수 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?
-------	--

	금주	금연
환자 상태	지금까지의 문진을 종합해 보았을 때 환자 분께서는 현재 알코올에 대한 의존도가 중증으로 매우 높은 알코올 사용장애가 의심이 됩니다. 또한 현재 소화불량 등의 증상이 오래된 것으로 보아 음주로 인해서 소화기에 문제가 생겼을 가능성이 있습니다. 이에 대해서 추가적으로 간기능 장애와 복부 초음파를 해보는 것이 좋을 것 같습니다. 괜찮으신가요?	지금까지의 문진을 종합해 보았을 때 환자분께서는 현재 니코틴의 의존도가 상당히 높은 것으로 확인되었습니다. 또한 현재 기침이나 가래 등의 증상이 오래된 것으로 보아 흡연으로 인해서 호흡기에 문제가 생겼을 가능성이 있습니다. 이에 대해서는 추가적으로 가슴 X-ray와 폐기능검사를 해보는 것이 좋을 것 같습니다. 괜찮으신가요?
격려 / 칭찬	그래도 이렇게 스스로 결심해서 병원을 찾은 것을 보면 의지가 굉장히 강하신 것 같아서 금주/금연을 꼭 성공하실 수 있을 것 같습니다. 술/담배를 단번에 끊기 보다는 점차 음주/흡연 횟수나 양을 줄이는 목표를 갖는 것이 좋을 것 같습니다.	
조력자 / 방해자	금주/금연을 하게 된다면 주변에서 환자분을 도와줄 사람이 있나요? 방해되는 사람은 있나요? → 주변에서 그 분들과 함께하면 도움이 극대화되므로 그분들도 이번 기회에 설득해서 같이 금주/금연을 하는 것이 금연 성공률을 더 높일 수 있을 것 같습니다.	
시작일	그러면 언제부터 금주/금연을 하기로 정할까요? (1~2주 내 특별한 날)	
전략	① 금주를 위해서 주변에 금주 사실을 알리는 게 좋습니다. ② 술자리를 가급적 피하세요. ③ 금주를 위해 단주 동맹이나 알코올 자조 단체가 있으니 함께 참여하시면 금주에 큰 도움이 될 것입니다. ④ 음주 일기를 쓰세요.	① 주변에 금연을 하기로 한 것을 많이 알리는 것이 좋습니다. ② 담배, 라이터, 재떨이 등 흡연에 필요한 물품들은 다 버리세요. ③ 한동안은 술 자리를 피하는 것이 금연하는 것에 도움이 되실 것입니다.
금단 증상 약물 처방	금단 증상은 2~3일째 가장 심하고, 이때 손떨림, 불면증, 메스꺼움, 구토, 환청, 환시, 경련, 불안, 식은땀, 두근거림 같은 증상들이 나타날 수 있습니다. 금단 증상이 심할 때에는 완화시켜 줄 수 있는 신경안정제 (Benzodiazepine)를 오늘 처방해 드릴테니, 드시기 바랍니다.	금연을 하게 되면 2~3일 정도에 금단 증상이 가장 심하게 나타날텐데, 5일 정도 지나면 증상이 감소하기 때문에 이때 굳건질거리나 손장난거리를 정해서 잘 이겨 내시는 것이 중요할 것 같습니다. 또한 적절한 운동을 해주시는 것도 도움이 되실 것입니다. 만약 스스로의 힘으로 어렵다면 약물요법을 추가적으로 시행할 수 있습니다.

금단 증상 약물 처방	또한 술에 대한 조절력 상실은 도덕적인 문제가 아니고 생물학적인 문제이기 때문에 약물 치료가 필요할 수 있습니다. 약물보조요법으로 몇 가지 약물을 처방해 드리겠습니다(Naltrexone, Acamprosate).	Nicotine 보충제	껌, 흡입제, 비강분무제, patch(접촉성 피부염, 불면증, 꿈 생생, 오심의 부작용)
		정신작용제	Bupropion (비전형적 항우울제)
		Nicotine 부분 효능제	Varenicline : 챔픽스(니코틴 역할을 함, 2주 사용 0.5mg → 1mg → 2mg까지 증량)
다음 방문	1~2주 후에 다시 한 번 외래에 방문하셔서 그 동안 어떤 것이 힘들었는지 어떻게 잘 지켰는지 확인하고 그에 따라서 조절해보도록 하겠습니다. 또한 신체적, 정신적으로 많이 힘이 드실 때는 언제든지 찾아오셔도 좋습니다. 1주일 뒤에 예약해 드려도 괜찮을까요? 네, 그럼 그때 뵙겠습니다.		
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?		

금주 상담

❖ 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, LFT, Amylase, kidney PANEL
- ② 영상검사 : 복부초음파

❖ 치료 계획

- ① Glucose 및 thiamine 보충
- ② 금단 증상 발생 시 benzodiazepine
- ③ 금주 모임 소개
- ④ 심리 치료
- ⑤ 약물 치료(형오디갈까 보나마나 대감집)
 - 혐오조건화 : disulfiram, Ca carbamide (현재 잘 안 쓰임)
 - 보상 효과 차단 : naltrexone
 - 대체요법(항갈망제) : acamprosate

* 알코올 금단증후군 : 금단 증상 중 2가지 이상 & 사회적, 직업적 장애

* 알코올 사용장애 : 남용과 의존 항목에서

- 1개 : 정상
- 2~3개 : 중등도 알코올 사용장애
- 4개 이상 : 중증 알코올 사용장애

금연 상담

❖ **Relevance(관련성)** : 현재 가지고 있는 증상이나 질환, 가족이나 건강에 대한 염려 등을 흡연과 관련지어 동기 유발 촉진

- ① 10대 : 구취, 치아 변색, 비용, 숨참, 인후통, 잦은 감기
- ② 임신부 : 자연유산, 태아 사망 위험 증가, 저체중아 위험 증가
- ③ 부모 : 흡연하는 부모 아이들이 기침과 호흡기 감염 증가
- ④ 성인 : 상기도 감염, 기침, 인후통, 치주 질환, 숨참, 궤양, 협심증, 손발 저림, 골다공증, GERD
- ⑤ 모든 : 비용, 기분, 운동 능력 저하, 노년기의 건강

❖ **Risk(위험도)** : 흡연과 관련된 위험 질환 제시, 설명

- ① 흡연은 모든 암의 30% 원인을 차지하며, 암 유발 촉진 인자를 함유하고 있습니다.
- ② 고혈압/고지혈증/관상동맥의 주요 위험 인자이며, 65세 이전 사망의 큰 원인이 됩니다.
- ③ 현재 무증상이더라도
 - 심장병, 폐기종, 폐암 등의 위험이 최대 10배나 높고, 평균 수명 5~8년 감소합니다.

❖ **Rewards(보상)** : 금연 시 얻을 수 있는 이득 설명

- ① 폐기능도 30% 이상 회복될 뿐 아니라 혈압과 맥박이 정상으로 돌아오고 손발 체온이 정상으로 유지됩니다. 신경 말단 기능도 돌아오고, 맛이나 냄새 감각도 좋아집니다. 또한 심장마비나 뇌졸중의 위험도가 감소하고, 혈액 순환 기능이 좋아지며, 폐암 사망률이 절반 수준으로 감소합니다.
- ② 남자의 경우 성 능력과 수정 능력, 정자 운동 능력이 회복됩니다.